PELVIS · PE-02

Masse annexielle · O-RADS

O-RADS US v2022 · O-RADS MRI
échographie puis IRM de caractérisation

O-RADS ÉCHOGRAPHIE V2022 · SCORE ET CONDUITE

SCORE	LÉSIONS TYPES	CONDUITE
0 incomplet	Lésion non caractérisable (technique, gaz, patiente)	Nouvelle échographie ou IRM
1 normal	Follicule ≤ 3 cm, corps jaune ≤ 3 cm (préménopause)	Aucune
2 < 1 %	Kyste simple < 10 cm ; kyste uniloculaire lisse non simple ou **biloculaire** lisse < 10 cm ; lésion bénigne classique < 10 cm (kyste hémorragique, endométriome, kyste dermoïde, kyste paraovarien, kyste d'inclusion péritonéal, hydrosalpinx)	Selon taille et statut ménopausique : rien, ou échographie à 6–12 mois (ex. kyste simple > 5 cm, uniloculaire non simple > 3 cm)
3 1–10 %	Kyste uni- ou biloculaire **≥ 10 cm** ; lésion bénigne classique ≥ 10 cm ; uniloculaire à paroi irrégulière (< 3 mm) ; multiloculaire lisse < 10 cm, score couleur 1–3 ; solide lisse score couleur 1 ; solide lisse **avec cône d'ombre** score couleur 2–3	Si non opérée : échographie à 6 mois ; si solide : expert ou **IRM (O-RADS MRI)** ; gynécologue
4 10–50 %	Multiloculaire sans composante solide ≥ 10 cm ou score couleur 4, ou à paroi/cloison irrégulière ; uniloculaire avec composante solide (1–3 végétations ou composante non papillaire) ; bi- ou multiloculaire avec composante solide score couleur 1–2 ; solide lisse sans cône d'ombre score couleur 2–3	Échographiste expert ou **IRM** ; gynécologue avec avis oncogynécologique
5 ≥ 50 %	Uniloculaire avec **≥ 4 végétations** ; bi- ou multiloculaire avec composante solide score couleur 3–4 ; solide lisse score couleur 4 ; **solide irrégulier** ; **ascite et/ou nodules péritonéaux**	**Oncogynécologue**

Score couleur (CS) : 1 aucun flux · 2 flux minime · 3 modéré · 4 intense. Végétation papillaire = composante solide ≥ 3 mm de hauteur faisant saillie dans le kyste. Le seuil de malignité retenu est O-RADS 4.

LEXIQUE ET PIÈGES ÉCHOGRAPHIQUES

Lésions bénignes classiques

- **Kyste hémorragique** : réseau réticulaire, caillot rétractile, pas de flux interne
- **Endométriome** : échos homogènes en verre dépoli, uni- ou biloculaire
- **Dermoïde** : hyperéchogénicité avec cône d'ombre, lignes et points, boules flottantes

Kystes et trompes

- **Hydrosalpinx** : tubulaire, plis endosalpingiens, septa incomplets
- **Kyste d'inclusion péritonéal** : épouse les contours, ovaire au bord ou dedans
- **Paraovarien** : simple, séparé de l'ovaire

Pièges

- Un caillot ou un tissu sans flux n'est pas une composante solide
- Composante solide sans flux : toujours considérée comme solide si certaine
- Ménopause : seuils plus bas pour le suivi

Masse annexielle · O-RADS (suite)

O-RADS IRM · SCORE DE RISQUE

SCORE	CRITÈRES
1 pas de lésion	Ovaires normaux ; follicule, corps jaune ou kyste hémorragique < 3 cm en préménopause
2 < 0,5 %	Kyste uniloculaire sans paroi rehaussée ni tissu solide (liquide simple, endométriome, contenu graisseux) ; hydrosalpinx, kyste d'inclusion péritonéal typique ; tératome mature sans tissu solide ; **tissu solide homogène très hypo-intense en T2 et en diffusion** (« sombre / sombre »)
3 ≈ 5 %	Kyste uniloculaire à liquide non graisseux avec paroi rehaussée lisse ; kyste multiloculaire sans tissu solide ; tissu solide (sauf sombre/sombre) avec **courbe de bas risque**
4 ≈ 50 %	Tissu solide (sauf sombre/sombre) avec **courbe de risque intermédiaire**, ou rehaussement ≤ myomètre à 30–40 s sans DCE ; lésion graisseuse avec **volume important de tissu solide rehaussé**
5 ≈ 90 %	Tissu solide avec **courbe de haut risque**, ou rehaussement **> myomètre externe à 30–40 s** sans DCE ; **nodules ou épaississement péritonéal, mésentérique ou épiploïque**

COURBES DE REHAUSSEMENT (DCE)

Bas risque
Ascension progressive **sans plateau**

Intermédiaire
Ascension initiale **moins raide** que le myomètre externe, **puis plateau**

Haut risque
Ascension initiale **plus raide** que le myomètre externe

PROTOCOLE IRM ET LECTURE

Protocole

- T2 dans 3 plans (dont un sans saturation de graisse), T1 en phase / opposition de phase, T1 avec saturation de graisse
- Diffusion (b ≈ 1 000) avec ADC
- T1 dynamique avec injection (résolution temporelle ≤ 15 s) puis tardif
- Antispasmodique ; vessie peu remplie

Lecture

- Définir d'abord : origine annexielle ? contenu (liquide, graisse, sang) ? **tissu solide** ?
- Tissu solide = papille, nodule mural, septum irrégulier ou portion solide qui se rehausse ; pas un caillot
- Comparer au **myomètre externe**, sur une région d'intérêt dans la partie la plus rehaussée

Quand l'IRM ?
O-RADS US 3–4 avec composante solide, lésion indéterminée en échographie

Sombre / sombre
tissu solide très hypo T2 et diffusion = fibrome ovarien, Brenner : bénin

Toujours décrire
ascite, carcinose, ganglions, ovaire controlatéral

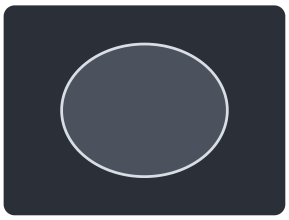
Masse annexielle · O-RADS (suite)

ATLAS VISUEL

Lésions types en échographie et score O-RADS



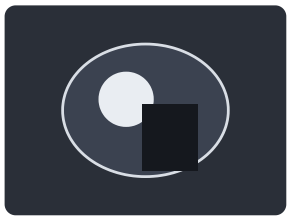
Kyste simple
anéchogène, paroi fine



Endométriome
échos homogènes



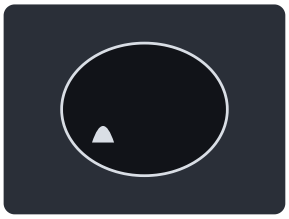
Kyste hémorragique
réticulaire, sans flux



Kyste dermoïde
hyperéchogène + cône d'ombre



Multiloculaire lisse
O-RADS 3 (< 10 cm, CS 1–3)



1–3 végétations
O-RADS 4



≥ 4 végétations
O-RADS 5



Solide irrégulier
O-RADS 5 (tout CS)

Schémas simplifiés, non à l'échelle · CS = score couleur (rouge = flux)

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

O-RADS US
Radiopaedia · lexique et scores
radiopaedia.org/articles/ovarian-adnexal-reporti

O-RADS IRM
Radiopaedia · score de risque
radiopaedia.org/articles/ovarian-adnexal-reporti

Endométriome
Radiopaedia · échographie et IRM
radiopaedia.org/articles/endometrioma?lang=us

Tératome kystique mature
Radiopaedia · signes typiques
radiopaedia.org/articles/mature-cystic-ovarian-t

ACR O-RADS IRM
Documents officiels
www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-an

Sources : O-RADS US v2022 (Radiology 2023) – divisionofresearch.kaiserpermanente.org/publications/o-rads-... · O-RADS US v2022 – tableau – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12849974/table/CD015717-tbl... · O-RADS MRI risk score – geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/uploads/sites/4... · O-RADS MRI (JMRI) – onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmri.28947 · ACR O-RADS MRI – www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-and-Reference/...